

1) Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar crónica en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x, PA: 110/76 mmHg, FC: 110x y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo oxígeno y salbutamol, sin respuesta. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaO₂: 50 mmHg, PaCO₂: 55 mmHg, pH: 7,29 y HCO₃: 27 mEq/L. La conducta más adecuada es: *Ac. Metabólica*

445 → 6

- a) Oxígeno por mascarilla al 100%
- b) Bicarbonato endovenoso
- ☒ c) Ventilación no invasiva
- d) Nebulizar con corticoides y salmeterol
- e) Ventilación mecánica invasiva

2) Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional, presenta un síndrome de dificultad respiratoria grave, con cianosis, taquipnea y uso de musculatura accesoria. Su examen pulmonar demuestra algunos crépitos y requiere FIO₂ de 0,6. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

- ☒ a) TAC de tórax
- b) Radiografía de tórax
- c) Hemocultivos y cultivos de expectoración
- d) Ecocardiografía
- e) Cateterismo cardíaco

3) Un recién nacido de 3 días de vida, presenta múltiples lesiones amarillentas, pequeñas, apenas sollevantadas en ambas alas nasales. La conducta más adecuada es:

- a) Corticoides tópicos
- b) Antimicóticos tópicos
- c) Vaselina líquida tópica
- d) Mantener el aseo habitual
- ☒ e) Antibióticos tópicos

4) Un paciente de 18 años, con antecedente de prótesis cardíaca valvular, consulta por malestar general, asociado a fiebre y artralgias. Al examen físico tiene FC: 100x, PA: 120/82 mmHg, T°: 38,8°C y se ausculta un soplo sistólico III/VI más un soplo diastólico II/VI en el precordio. Su hemograma muestra leucocitosis de 12.000 por mm³, con 70% de neutrófilos y VHS: 50 mm/h. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de este paciente?

- ☒ a) Ecocardiografía
- b) Radiografía de tórax
- c) Punción lumbar
- d) Proteína C reactiva
- e) Cateterismo cardíaco

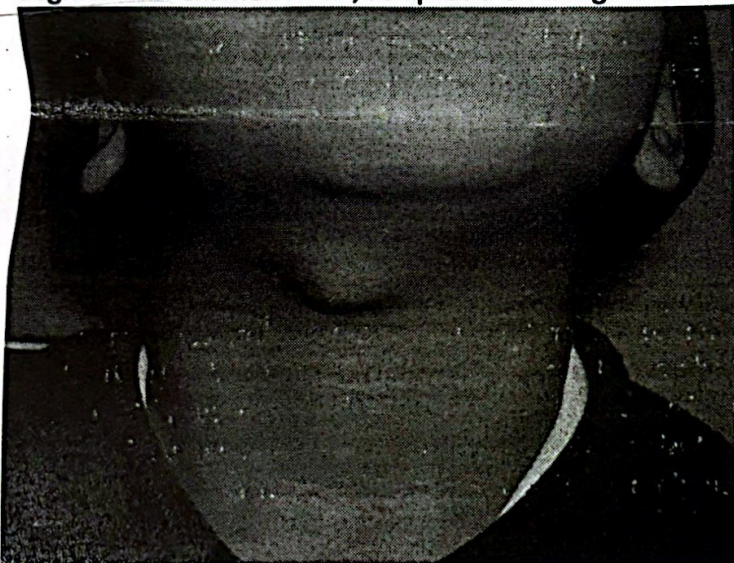
5) Una paciente de 81 años consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, asociada a paroxística nocturna y ortopnea. Al examen físico se objetiva PA: 160/60 mmHg, con pulso regular, amplio, a 72 lpm. Su examen cardíaco muestra desplazamiento del choque cardíaco, con presencia de un soplo intenso, entre el segundo y el primer ruido cardíaco, que se irradia al cuello. El examen pulmonar muestra crepitaciones escasas, en ambas bases. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Insuficiencia tricuspídea
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia aórtica - *cuello*
- d) Estenosis mitral
- e) Insuficiencia mitral

6) Una niña de 14 años aún no ha tenido su menarquia. Al examen físico no presenta desarrollo puberal y tiene talla baja. Como antecedente, fue operada de una coartación aórtica hace varios años. ¿Cuál es el examen más adecuado para seguir con el estudio en esta paciente?

- a) Niveles de FSH ✓
- b) Hormona antimülleriana ✗
- c) Edad ósea
- d) Niveles de estradiol ✓
- e) Cariograma ✓

7) Un niño de 7 años presenta aumento de volumen en el cuello, que se desplaza con la deglución. El examen físico, se aprecia en la siguiente imagen.



¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

- a) TAC de cuello
- b) Ecografía de cuello
- c) Radiografía de cuello
- d) Cintigrafía con yodo radiactivo
- e) Captación de yodo radiactivo

8) Un hombre de 31 años consulta por aumento de volumen en el cuello, que se palpa como un nódulo tiroideo de consistencia firme. Es estudiado con ecografía, que muestra un nódulo hiopocogénico, sólido, heterogéneo, de 1,3 cm. La TSH: resulta 3,0 UI/L. ¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?

- a) TAC de cuello
- b) Biopsia excisional del nódulo
- c) Biopsia citológica
- d) Cintigrafía con yodo radiactivo
- ☒ e) Seguimiento ecográfico —

9) Una paciente de 22 años presenta un nódulo mamario, en el lado derecho. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, de consistencia gomosa, que no está adherido a la piel, ni a planos profundos. No tiene otras alteraciones. El examen más adecuado para iniciar el estudio es:

- ☒ a) Ecografía mamaria
- b) Mamografías bilaterales
- c) Punción con aguja fina
- d) Resonancia magnética nuclear
- e) Extirpación y biopsia de la pieza quirúrgica

10) Una paciente de 30 años se realiza un PAP, que resulta atípico de alto grado, por lo que se realiza una colposcopia y biopsia, que es informada como NIE-1, de localización exocervical. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Seguimiento con PAP
 - b) Crioterapia
 - ☒ c) Cono cervical
 - d) Tipificación de virus papiloma humano
 - e) Diatermocoagulación
- conectarse*

11) Una paciente de 32 años tiene un cuadro de náuseas y dolor abdominal, que es mayor luego de comer y en las tardes. Su examen físico no tiene alteraciones. Se solicita una ecografía abdominal, que visualiza un pólipo en la vesícula biliar, de 4 mm de diámetro y aspecto homogéneo, sin presencia de cálculos. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar colecistectomía laparoscópica
- b) Solicitar endoscopia digestiva alta
- ☒ c) Realizar seguimiento con ecografía en 6 meses
- d) Realizar colangiografía
- e) Realizar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

12) Múltiples estudios demuestran que un factor de riesgo tiene un riesgo relativo entre 3 y 4 para la aparición de una enfermedad. ¿A qué criterios de causalidad de Hills corresponde esto?

- a) Replicabilidad
- b) Congruencia
- ☒ c) Plausibilidad biológica
- d) Secuencia temporal
- e) Asociación

13) Una lactante de 2 meses con cuadro de dolor abdominal y vómitos desde hace semanas que en las últimas horas ha empeorado asociándose fiebre, taquipnea y compromiso de conciencia. Al su ingreso destaca PA: 40/20, FC 130x', examen pulmonar con crépitos difusos. Se solicitan exámenes de laboratorio donde destaca creatinina 0.9, glicemia 40, Na⁺ 132, K⁺ 5.7, hemograma con leucocitosis. Se inicia Ceftriaxona y aporte de suero fisiológico en bolo sin respuesta luego de una hora. El fármaco de elección para el manejo de esta paciente es:

- a) Vancomicina
- b) Noradrenalina
- c) Hidrocortisona
- d) Vasopresina
- e) Dopamina

14) Una paciente de 30 años, con embarazo de 35 semanas controlado, consulta al servicio de urgencias por metrorragia escasa, asociada a dolor abdominal. Al examen físico destaca aumento marcado del tono uterino de forma permanente y frecuencia cardíaca fetal de 110 por minuto. El diagnóstico más probable es:

- a) Placenta previa
- b) Rotura uterina
- c) Rotura de vasa previa
- d) Síntomas de parto prematuro
- e) Desprendimiento de placenta

15) Un paciente de 50 años, diabético en tratamiento con metformina, consulta por polaquiuria, nicturia, latencia y debilidad del chorro miccional desde hace meses, no asociado a otros síntomas. Su tacto rectal muestra próstata aumentada de tamaño de consistencia gomosa. Con respecto a este caso, ¿Cuál de las siguientes es una indicación absoluta para resolución quirúrgica en esta patología?

- a) Hematuria en una ocasión
- b) Retención aguda de orina
- c) Residuo postmiccional de 150 ml
- d) Próstata mayor a 40 cc
- e) Antígeno prostático de 5 ng/ml

16) Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él "no puede hacerlo". Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

- a) Trastorno de pánico
- b) Trastorno de la personalidad evitativo X
- c) Ansiedad social
- d) Trastorno de ansiedad generalizada
- e) Agorafobia

17) Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. El diagnóstico más probable es:

- a) Luxación anterior de cadera
- b) Fractura intertrocanterica
- c) Fractura de cuello femoral
- ☒ d) Luxación posterior de cadera
- e) Fractura de pelvis

18) Paciente de 30 años, sufre caída de altura resultando con traumatismo contuso en flanco derecho, asociado a hematuria macroscópica. Al examen físico presenta equimosis en flanco derecho, sin otros hallazgos. ¿Cuál de los siguientes exámenes es el más indicado para el estudio de este paciente?

- a) Ecografía abdominal
- ☒ b) Tomografía axial computada sin contraste de abdomen
- c) Radiografía abdominal
- d) Tomografía axial computada con contraste de abdomen
- e) Pielografía de eliminación

Urotac.

19) Paciente de 34 años, consulta por cuadro de un mes de compromiso del estado general, tos persistente con expectoración mucopurulenta y en dos ocasiones hemoptoica. Al examen físico destaca sudoroso, frecuencia cardíaca de 60 por minuto, presión arterial de 120/70, examen cardíaco normal y pulmonar con murmullo presente, crepitaciones y sibilancias difusas mayores en ápice izquierdo. El examen más adecuado para el diagnóstico en este caso es:

- ☒ a) Baciloscopías seriadas
- b) Prueba cutánea de tuberculina
- c) Radiografía de tórax
- d) TAC de tórax multicorte
- e) Hemocultivo

20) Paciente de 29 años, cursando embarazo de 38 semanas, consulta por aparición de vesículas dolorosas a nivel vulvar, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecian vesículas con base eritematosa a nivel vulvar. El examen de elección para el diagnóstico etiológico en este caso es:

- a) Cultivo viral
- ☒ b) PCR para virus herpes
- c) Biopsia
- d) Inmunoglobulina G para virus herpes
- e) Tinción para virus herpes

21) Una paciente de 12 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de hemorragia gingival al lavarse los dientes, asociado a equimosis frente a pequeños traumatismos desde hace 2 semanas. Al examen físico destacan dichas equimosis y petequias generalizadas, sin otros hallazgos. Se solicita hemograma donde destaca hemoglobina de 12mg/dL, leucocitos de 7.000/mm³ y plaquetas de 4.000/mm³. El tratamiento de elección en este caso es:

- a) Transfusión de plaquetas
- b) Esplenectomía
- ☒ c) Corticoides
- d) Inmunoglobulina no específica
- e) Administrar crioprecipitado

22) Un paciente de 6 años, con historia de 5 días de odinofagia intensa asociada a secreción purulenta y sensación febril que durante el último día se acompañó de rash papular eritematoso que es más intenso en pliegues. El examen de elección para el diagnóstico en este caso es:

- a) Hemograma
- b) IgM para virus Epstein Baar X
- c) Panel viral
- d) Cultivo de secreción faríngea
- e) Test pack para Estreptococo grupo A

23) Mujer de 29 años, cursando embarazo de 33 semanas, consulta por presentar metrorragia escasa en una oportunidad no asociado a otros síntomas. Ha mantenido actividad sexual regular, durante todo el embarazo. Al examen físico no se aprecia sangre proveniente del orificio cervical externo, resto normal. Se realiza registro basal no estresante que resulta reactivo. El diagnóstico más probable en este caso es:

- a) Rotura de vasa previa
- b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera
- c) Placenta previa
- d) Rotura uterina X
- e) Sinusorragia

24) Paciente de 23 años, sin antecedentes, con cuadro de 2 semanas de rinorrea y coriza, que durante los últimos dos días se asocia a compromiso del estado general, sensación febril, tos con expectoración mucopurulenta y disnea. Al examen físico presenta signos vitales dentro de rangos normales, murmullo pulmonar presente en ambos campos pulmonares asociado a crepitaciones en base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que muestra infiltrado intersticial en base derecha. El tratamiento de elección de esta patología es:

- a) Azitromicina
- b) Amoxicilina-ácido clavulánico
- c) Clindamicina
- d) Ceftriaxona
- e) Moxifloxacino

25) Un hombre de 48 años, diagnosticado de esquizofrenia, presenta episodio agitación, por lo cual se aumenta la dosis de haloperidol de 10 a 20 mg al día, evolucionando con malestar general, dificultad para la marcha y disminución del nivel de conciencia. Al examen físico, tiene FC: 100x', PA: 140/90 mmHg, temperatura 38 grados Celsius y rigidez de las extremidades. Se solicitan exámenes, en los que destaca leucocitosis de 19.000 blancos por mm³ y CPK de 1200 UI/L. El diagnóstico más probable es:

- a) Distonía
- b) Síndrome neuroléptico maligno
- c) Síndrome anticolinérgico
- d) Síndrome adrenérgico
- e) Distrofia muscular de Duchenne

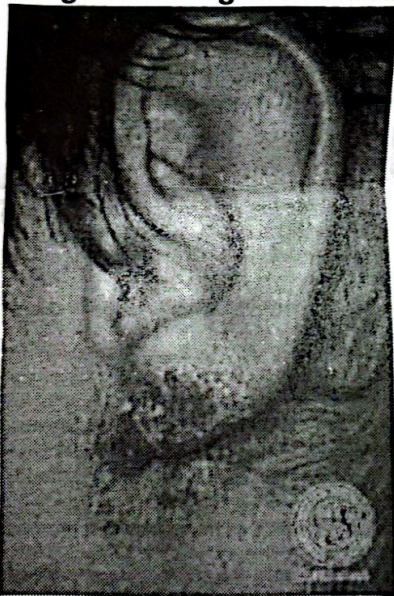
26) En la vigilancia de las enfermedades transmisibles, ¿cuál es el parámetro que se utiliza para definir si la notificación de los casos de dicha enfermedad es de tipo diaria o inmediata?

- a) Periodo de incubación
- b) Oportunidad de control y prevención, de acuerdo a su contagiosidad
- c) Prevalencia —
- d) Número de casos
- e) Disponibilidad de vacuna

27) Una mujer de 26 años, presenta un cuadro de 5 días de rinorrea, que a los dos días se vuelve mucopurulenta, agregándose odinofagia, y congestión nasal. Al examen físico se aprecia rinorrea, asociada a eritema y congestión faríngea. Se solicita una radiografía de senos paranasales que muestra velamiento de ambos senos maxilares. El tratamiento más adecuado es:

- a) Amoxicilina oral
- b) Amoxicilina más ácido clavulánico oral
- c) Corticoide tópico
- d) Descongestionantes tópicos
- e) Antihistamínicos orales

28) Una adolescente de 15 años presenta lesiones en ambas orejas, que se extienden hasta el cuello. Tiene antecedente de hacerse piercings, hace una semana. Al examen físico se observa la siguiente imagen:



El diagnóstico más probable es:

- a) Celulitis
- b) Erisipela
- c) Dermatitis de contacto alérgica
- d) Dermatitis de contacto irritativa
- e) Piodermitis superficial

29) Una paciente de sexo femenino de 17 años de edad, con antecedente de relaciones sexuales sin protección, consulta prurito vulvar, asociado a ardor progresivo. Refiere sensación de aumento del volumen de la vulva, que luego fue seguido por los síntomas actuales. Al examen físico se observa lo expuesto en la siguiente imagen.



Se trata de una infección por:

- a) Treponema pallidum X
- b) Virus herpes simplex
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Virus papiloma humano
- e) Ureaplasma urealyticum

30) Una paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión arterial, en tratamiento con hidroclorotiazida, presenta un cuadro de diarrea y vómitos, seguido de compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor profundo, con PA: 80/50 y frecuencia cardíaca de 120x', regular, con sequedad de mucosas. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran natremia: 156 mEq/L, cloremia: 114 mEq/L, potasemia: 3,1 mEq/L, pH: 7,40, bicarbonato: 14 mmol/L, CO₂: 20 mmHg. ¿Cuál de los siguientes fluidos se debe administrar en primer lugar?

- a) Suero glucosado al 5% ev X
- b) Suero fisiológico al 0,9% ev
- c) Solución de bicarbonato al 2/3 molar ev
- d) Agua por sonda nasogástrica
- e) Sales de rehidratación oral

31) Una paciente de 42 años se realiza una histerectomía radical, por un cáncer de cuello uterino. Evoluciona con bochornos, cefalea y dispareunia profunda, por resequedad vaginal. Al examen físico tiene sobrepeso y presión arterial normal. Además, trae exámenes en los que destaca Colesterol total: 204 mg/dl, Colesterol HDL: 54 mg/dl, Triglicéridos: 405 mg/dl. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

- a) Estrógenos más progestágenos orales X
- b) Estrógenos orales
- c) Estrógenos en parches
- d) Progestágenos endovaginales X
- e) Sertralina

32) Una paciente de 25 años, con atraso menstrual de 3 semanas, consulta por dolor abdominal de 5 días de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta abdomen doloroso a la palpación abdominal baja, mayor en la fosa iliaca izquierda, sin signos peritoneales. Además, se realiza una HCG, que resulta 5.500 UI/L y se solicita una Ecografía Transvaginal, que visualiza útero sin gestación intrauterina, con endometrio de 15 mm, y un tumor anexial izquierdo de 53 mm de diámetro, de aspecto complejo, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Realizar laparoscopia exploradora
- b) Realizar laparotomía exploradora
- c) Indicar metotrexato
- d) Solicitar ecografía en 7 días
- e) Solicitar niveles de HCG y ecografía en 48 horas

33) Una paciente de 46 años, nulípara, sin método anticonceptivo, presenta una metrorragia, que es manejada con legrado uterino. La biopsia demuestra presencia de hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Repetir el legrado en 3 meses
- b) Implantar DIU medicado con progestágenos
- c) Realizar histerectomía total
- d) Indicar progestágenos cíclicos
- e) Indicar progestágenos continuos

34) Un niño de 5 meses de edad presenta un cuadro de rinorrea y tos, que va en aumento, hasta presentar accesos de tos y dificultar la alimentación. Al examen físico está en buenas condiciones generales, afebril y sin alteraciones en el examen cardiopulmonar. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis de 17.000, con 78% de linfocitos y 22% de neutrófilos. La PCR y VHS están levemente elevadas. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial leve. El diagnóstico más probable es:

- a) Neumonía atípica
- b) Infección por virus influenza
- c) Infección por adenovirus
- d) Coqueluche
- e) Bronquiolitis aguda

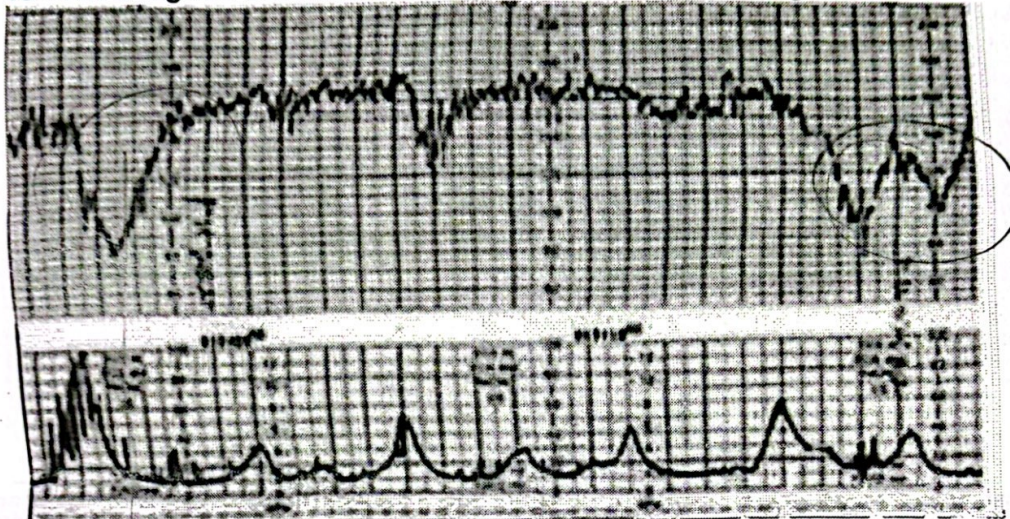
35) Un paciente de 64 años, con antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo, presenta pérdida de la visión del ojo izquierdo, con instalación súbita. Al examen, es capaz de distinguir la luz de la sombra y contar dedos y destaca defecto pupilar aferente relativo. El diagnóstico más probable es:

- a) Glaucoma agudo
 - b) Glaucoma crónico terminal
 - c) Neuritis óptica
 - d) Neuropatía óptica isquémica
 - e) Desprendimiento de retina
- trombo.

36) Paciente femenina, de 17 años presenta astenia, decaimiento, dolores óseos y pérdida de peso, de 2 meses evolución. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías cervicales y axilares, con bazo palpable 3 cm debajo del reborde costal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☒ a) Linfoma de Hodgkin .
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Leucemia linfática aguda
- d) Síndrome mononucleósico
- e) Leucemia linfática crónica

37) Una mujer de 45 años, múltipara de 3, cursando un cuarto embarazo de 40 semanas, inicia trabajo de parto. Está en fase activa, con presentación en cefálica, con 8 cm de dilatación cervical. El registro de la frecuencia cardíaca fetal muestra lo siguiente:



Deceleración

Luego de 30 minutos, no hay cambios en el registro. La conducta más adecuada es:

- a) Dejar que evolucione espontáneamente
- ☒ b) Realizar cesárea de urgencia —
- c) Iniciar aceleración oxitócica
- d) Realizar fórceps
- e) Administrar tocolíticos

38) Al evaluar a un paciente que padece una esquizofrenia resistente al tratamiento la primera medida a considerar será:

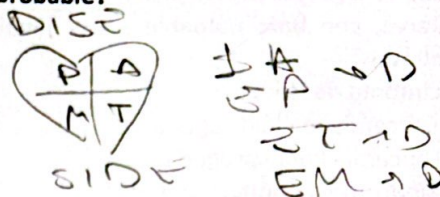
- a) Uso de terapia electroconvulsiva
- b) Pasar el paciente a un antipsicótico atípico
- ☒ c) Verificar que el paciente estuviera cumpliendo el tratamiento prescrito —
- d) Ingresar al paciente en un hospital
- e) Añadir un tratamiento psicoterapéutico

39) Un paciente de 58 años consulta por hipoacusia y otorrea izquierda, de algunos meses de evolución. Además, refiere otalgia ipsilateral, con cierta frecuencia. ¿Qué examen es más adecuado para evaluar a este paciente?

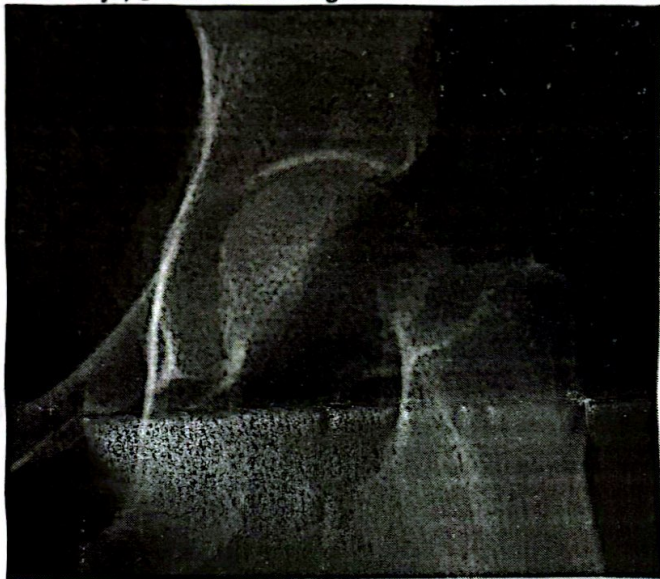
- a) TAC de oído
- b) Audiometría
- c) Impedanciometría
- ☒ d) Otoscopía
- e) Emisiones otoacústicas

40) Un paciente de 58 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos y disnea paroxística nocturna. Al examen físico presenta un soplo cardíaco diastólico, de tonalidad baja y chasquido de apertura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Estenosis mitral ?
- b) Estenosis aórtica
- c) Insuficiencia mitral
- ☒ d) Insuficiencia aórtica
- e) Miocardiopatía dilatada



41) Hombre de 84 años sin antecedentes personales de interés que acude a urgencias tras sufrir un accidente en motocicleta. Presenta exclusivamente un traumatismo en la cadera izquierda que clínicamente se manifiesta por dolor en región inguinal, impotencia funcional y deformidad del miembro en rotación externa. A la vista del estudio radiológico que se muestra más abajo, ¿Cuál es de los siguientes se considera el tratamiento de elección?



- a) Tracción transesquelética durante 3 semanas y descarga del miembro hasta tercer mes
- b) Reducción cerrada y osteosíntesis
- ☒ c) Artroplastía parcial de cadera
- d) Artroplastía total de cadera
- e) Reducción abierta e inmovilización con yeso pelvipédico, durante seis semanas

42) Un paciente de 50 años asegura que su vecino lo aborrece y que trata de perjudicarlo constantemente. Para ello habla mal de él a sus espaldas y le ocupa el siempre estacionamiento que a él le gusta en la calle. Además, cree que el vecino saca a su perro a la vereda, para que la ensucie, solo para molestarlo. El vecino niega todos los hechos, no tenía idea de que todo esto estaba pasando y de hecho tenía una buena impresión del paciente, por lo que está extrañado y asustado de que él crea esas cosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

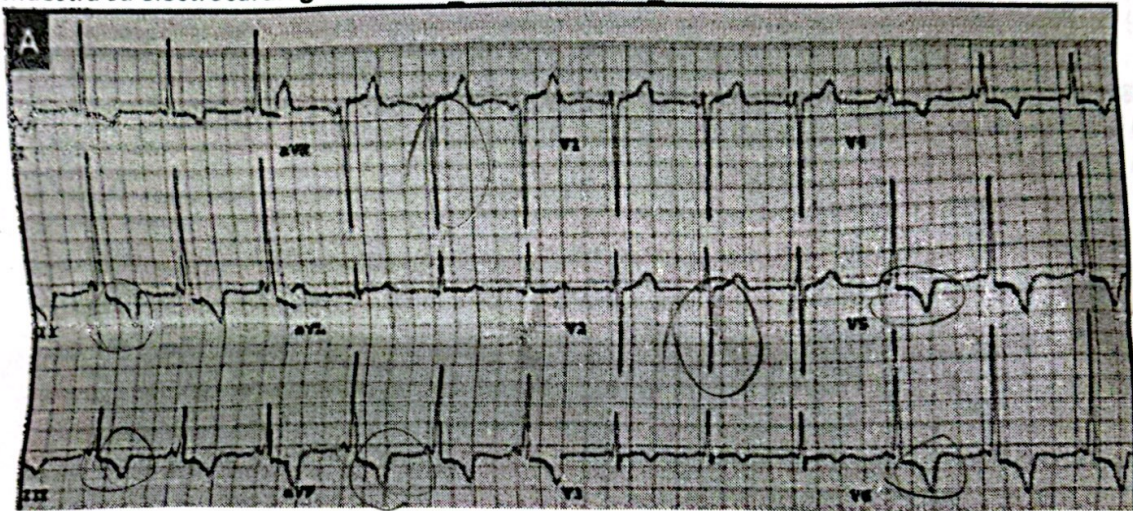
- ☒ a) Trastorno delirante crónico
- b) Trastorno de personalidad paranoide
- c) Esquizofrenia
- d) Trastorno bipolar
- e) Trastorno obsesivo compulsivo

43) Un paciente de 80 años presenta un cuadro de astenia y disnea de esfuerzos. Su examen físico es normal, por lo que se solicitan exámenes generales, entre los que destaca un hemograma con hemoglobina de 9,5 g/dl y hematocrito de 28%. Su VCM es de 70 fl y sus plaquetas y glóbulos blancos son 340.000 y 6.000 por mm³, respectivamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Anemia por insuficiencia renal
- b) Talasemia
- c) Anemia por enfermedades crónicas ✓
- d) Anemia ferropénica ✓
- e) Anemia por déficit de vitamina B12

Anemia microcítica

44) Una paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial de larga data, consulta por disnea de esfuerzos, que aparece al caminar dos cuadras. Además, refiere que debe dormir semisentada, ya que de lo contrario se siente ahogada en la noche. Al examen físico presenta PA: 166/100 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 15 rpm. Su auscultación cardíaca muestra un RR2T sin soplos y su auscultación pulmonar muestra crepitaciones en ambas bases pulmonares. Se muestra su electrocardiograma:



¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cardiopatía coronaria ✓
- b) Infarto agudo al miocardio de la pared anterolateral
- c) Cardiopatía hipertensiva
- d) Miocardiopatía hipertrófica ✓
- e) Síndrome de Brugada ✓

45) Un paciente de 65 años, presenta un cuadro de agitación psicomotora y asegura que lo quieren matar. Sus familiares están muy preocupados porque nunca le había pasado algo así. El diagnóstico más probable es:

- a) Delirium ✓
- b) Demencia tipo Alzheimer
- c) Esquizofrenia
- d) Accidente vascular encefálico
- e) Trastorno delirante

46) Una paciente cursa u embarazo de 33 semanas, con controles normales hasta ese momento. Consulta por dinámica uterina persistente, de una hora de evolución. Al examen físico se constatan contracciones uterinas cada 3 minutos y se palpa un cuello borrado, con 1 cm de dilatación y membranas íntegras. La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Administrar antibióticos y corticoides
- c) Administrar tocolíticos y corticoides
- d) Administrar antibióticos y tocolíticos
- e) Realizar cesárea

47) Un paciente inmunodeprimido, por déficit parcial de inmunoglobulinas, presenta una neumonía adquirida en la comunidad. Se realiza estudio etiológico e inicia tratamiento con ceftriaxona endovenosa. Al día siguiente se constata desarrollo de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente?

- a) Amoxicilina + ácido clavulánico
- b) Ceftriaxona
- c) Clindamicina
- d) Vancomicina
- e) Cotrimoxazol

3 MAR

48) El retraimiento social y el desinterés en las relaciones interpersonales es característico de:

- a) El trastorno de personalidad paranoide
- b) El trastorno de personalidad limítrofe
- c) El trastorno de personalidad esquizoide
- d) El trastorno de personalidad evitativo
- e) El trastorno de personalidad antisocial

49) ¿Qué institución da la autorización sanitaria para el funcionamiento de laboratorio y clínicas?

- a) Superintendencia de Salud
- b) Secretaría Regional Ministerial de Salud
- c) Corporaciones Municipales de Salud
- d) Dirección del Servicio de Salud
- e) Superintendencia de Seguridad Social

50) Un paciente de 80 años, consulta por cuadro de disnea de un mes de evolución que ha aumentado en el último tiempo, asociado a baja de peso. Al examen físico presenta disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax izquierdo con matidez a la percusión. Se solicita radiografía de tórax que muestra presencia de derrame pleural derecho, el que se punciona, dando salida a un líquido pleural con LDH de 300mg/dL, colesterol 60mg/dL, ADA 15 UI, leucocitos 3.000/mm3 con predominio mononuclear. El examen de elección para proseguir con el diagnóstico es:

- a) Broncoscopía
- b) Videotoracoscopia
- c) Ecografía pleural
- d) Ecocardiografía
- e) TAC de tórax

CLIC CA

51) Un paciente de 50 años, en tratamiento con antimicóticos orales desde hace 3 semanas, consulta por un cuadro de 2 días de evolución de prurito, ictericia y acolia sin dolor. En su examen físico se aprecia ictérico, afebril, con FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, con abdomen blando, depresible. Se solicitan pruebas hepáticas, que muestran un patrón colestásico y la ecografía abdominal demuestra vesícula biliar con barro biliar y colédoco de 10 mm diámetro.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Coledocolitiasis
- b) Colestasia farmacológica
- c) Síndrome de Mirizzi
- d) Esteatosis hepática
- e) Colelitiasis

52) Un paciente de 60 años, con antecedente de depresión, en tratamiento con paroxetina 40 mg en la noche y clonazepam 0,5 mg en la noche, hace 7 días disminuyó la dosis de los fármacos a la mitad. Hace 4 días inicia un cuadro de malestar general, asociado a inquietud, insomnio, sensación de pinchazos eléctricos en los brazos y miedo a morir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Acatisia
- b) Síndrome de discontinuación de antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- c) Síndrome de privación de benzodiacepinas
- d) Manía aguda
- e) Delirium

53) ¿A qué tipo de medida corresponde la vacunación contra una enfermedad, en la historia natural de una enfermedad?

- a) Promoción de salud
- b) Protección específica
- c) Erradicación de la enfermedad
- d) Diagnóstico oportuno
- e) Tratamiento precoz

54) Una paciente de 35 años, está en trabajo de parto de término. Durante el expulsivo, se produce desprendimiento de la cabeza fetal, sin embargo, no se produce la rotación ni el descenso de los hombros. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- a) Traccionar la cabeza fetal
- b) Realizar compresiones suprapúbicas
- c) Realizar hiperflexión de las caderas (maniobra de McRoberts)
- d) Realizar rotación manual de los hombros hacia anterior (maniobra de Rubin)
- e) Realizar extracción del brazo posterior (Maniobra de Jacquemier Barnum)

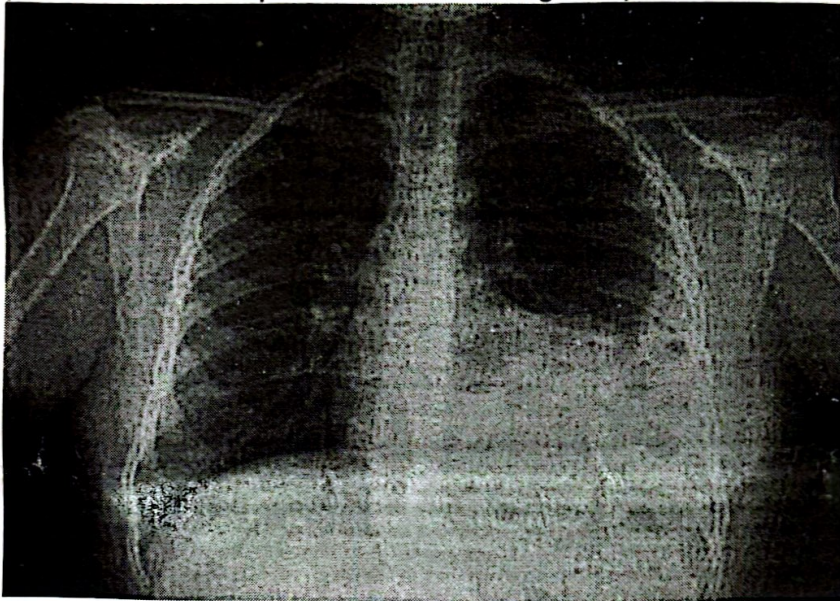
55) Una paciente de 19 años, con ciclos menstruales regulares, consulta por dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Su FUR fue hace 20 días. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la FII, con signos peritoneales esbozados. Se solicita test de embarazo, que resulta negativo y una ecografía transvaginal, que muestra una lesión anexial mixta de 8 cm de diámetro, con presencia de líquido libre en moderada cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Cuerpo lúteo hemorrágico
- b) Cuerpo lúteo roto
- c) Apendicitis aguda
- d) Torsión ovárica
- e) Absceso tubo-ovárico

56) Un paciente de 23 años consulta por odinofagia intensa, asociada a fiebre, que han empeorado y que en el último tiempo se agrega dificultades para comer, por trismus. Al examen físico presenta eritema faríngeo, exudado amigdalino bilateral y abombamiento del pilar diafragmático derecho. El diagnóstico más probable es:

- a) Absceso retrofaríngeo
- b) Angina de Ludwig
- c) Amigdalitis ulcero-necrótica
- ☒ d) Absceso periamigdalino
- e) Mononucleosis infecciosa

57) Un paciente de 40 años, consulta por disnea desde hace 2 semanas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia matidez a la percusión y disminución del murmullo pulmonar en base izquierda. Se realiza radiografía que se muestra a continuación:



El examen más adecuado para seguir con el estudio es:

- a) TAC
- b) AngioTAC
- c) Ecocardiografía
- ☒ d) Análisis citoquímico del líquido pleural
- e) Ecografía pleural

58) Un hombre de 77 años, alérgico a la penicilina, consulta por dolor de la rodilla izquierda, asociado a aumento de volumen y fiebre. Al examen físico tiene temperatura de 38,5 grados y presenta aumento de volumen y eritema de la rodilla izquierda, asociado a signos de derrame articular. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

- a) Cefazolina endovenosa
- ☒ b) Cloxacilina endovenosa
- c) Azitromicina oral
- d) Clindamicina endovenosa
- e) Gentamicina endovenosa

Neumococo?

59) Un paciente de 65 años consulta por dolor escrotal derecho de 3 días de evolución. Al examen físico presenta dolor y eritema en la zona escrotal derecha y se palpa aumento de volumen y dolor, del testículo y del epidídimo. Refiere tener pareja sexual monogámica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- a) Streptococcus pyogenes
- b) Staphylococcus aureus
- c) Chlamydia trachomatis
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) Escherichia coli

60) Una paciente de 24 años, que hace 1 semana inicia cuadro de fiebre, dolores osteoarticulares, ictericia. Como antecedente, hace tres semanas regresó de un viaje al caribe. Se solicitan exámenes que muestran GOT: 1.210 UI/L, GPT: 1.120 UI/L, bilirrubina de 12 mg/dL. El examen inicial para el diagnóstico etiológico es:

- a) IgG anti VHA
- b) Anticuerpos anti VHC
- c) Ag VHBs
- d) IgM VHA
- e) Anticuerpos antinucleares

61) Un paciente de 39 años, diagnosticado de VIH, sin tratamiento y con controles irregulares, consulta por diarrea de 3 meses de evolución, que ha ido en aumento. La diarrea es acuosa, sin sangre. Se solicitan exámenes entre los que destacan linfocitos CD4 de 30 por mm³. ¿Qué agente etiológico es más compatible con este cuadro?

- a) Citomegalovirus
- b) Toxoplasma gondii
- c) Pneumocystis jirovecii
- d) Criptosporidium
- e) Criptococo

62) Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina en dosis máxima, acude a control, constatándose creatinina 2,0 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 8,5%. La conducta más adecuada es:

- a) Reemplazar la metformina por una glitazona
- b) Agregar glibenclamida al tratamiento
- c) Iniciar insulina
- d) Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
- e) Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral

63) Un paciente presenta pérdida de la sensibilidad termalgésica de las 4 extremidades, mayor en las extremidades inferiores, de predominio distal. Al examen físico se aprecia atrofia de la musculatura de los pies. El diagnóstico más probable es:

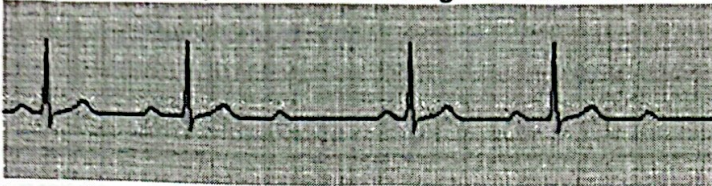
- a) Síndrome de Guillain Barré
- b) Polineuropatía
- c) Esclerosis lateral amiotrófica
- d) Esclerosis múltiple
- e) Miastenia gravis

Atrofia musculatura?

64) Un paciente de 28 años presenta un cuadro de diarrea crónica, asociada a baja de peso de 8 kilogramos en el último año. Previamente refería diarrea con frecuencia y en ocasiones dolor abdominal y flatulencia. No ha presentado otros síntomas y su examen físico es normal. Sus deposiciones son pastosas, brillantes, sin sangre y en sus exámenes de sangre destaca anemia ferropénica. El diagnóstico más probable es:

- a) Colopatía funcional
- b) Colitis ulcerosa
- c) Enfermedad de Cröhn
- d) Enfermedad celíaca
- e) Amebiasis intestinal

65) Un paciente hipertenso, asintomático se realiza un electrocardiograma, como parte de su chequeo habitual, constatándose el siguiente trazado:



La conducta más adecuada es:

- a) Observar evolución
- b) Solicitar un Holter de arritmias
- c) Derivar para marcapasos definitivo
- d) Iniciar propranolol
- e) Iniciar amiodarona

66) Niña de 12 años presenta fiebre intermitente de 2 semanas de evolución, acompañada en algunas oportunidades de un rash eritematoso, que compromete el tronco y la zona proximal de las extremidades que desaparece al ceder la fiebre. No presenta otros síntomas. Al examen físico se constata artritis de tobillo derecho y de la tercera y cuarta articulaciones metacarpofalángica izquierdas. El manejo inicial más adecuado, es:

- a) Iniciar inmunoglobulina G endovenosa y aspirina oral
- b) Iniciar corticoides orales
- c) Iniciar naproxeno vía oral
- d) Indicar paracetamol oral y enviar a domicilio
- e) Iniciar tratamiento antibiótico

67) Una paciente de 18 años presenta fiebre, astenia, artralgias y hematuria. Al examen físico se aprecia artritis de manos y úlceras orales no dolorosas. En sus exámenes generales destaca elevación de la creatinina hasta 3,5 mg/dL y hematuria dismórfica. El diagnóstico más probable es:

- a) Infección por virus herpes
- b) Enfermedad de Behcet
- c) Lupus eritematoso
- d) Vasculitis sistémica
- e) Púrpura de Schonlein Henoch

68) Un paciente de 80 años presenta un cuadro de dolor abdominal intenso, localizado en la fosa iliaca izquierda, de 6 horas de evolución y que ha ido en aumento. Al examen físico se constata signo de Blumberg en la zona. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de este paciente?

- a) Ninguno, basta la clínica y debe proceder a tratamiento quirúrgico
- b) Ninguno, debe indicarse alta y enviar a domicilio con antiespasmódicos orales
- c) La colonoscopia
- ☒ d) La tomografía axial computada
- e) La ecografía abdominal

69) Un paciente es diagnosticado de úlcera gástrica, mediante colonoscopia. Su test de ureasa es positivo, por lo que se decide realizar erradicación de Helicobacter pylori, con amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Dos meses después se realiza una endoscopia de control, que visualiza desaparición de la úlcera y negatividad de la prueba de ureasa. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☒ a) Observar evolución
- b) Indicar erradicación con fármacos de segunda línea
- c) Indicar omeprazol a permanencia
- d) Solicitar niveles de gastrina
- e) Iniciar antihistamínicos H2

70) Un paciente de 76 años consulta por insomnio y problemas de memoria. Al examen físico está en buenas condiciones, atento, colaborador, sin problemas de memoria evidente. Se muestra muy preocupado y se siente inútil y solo. Su minimental es de 28/30 y su GDS de 13/15. ¿Qué tratamiento es el más indicado?

- ☒ a) Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
- b) Antidepresivos duales
- c) Antidepresivos tricíclicos
- d) Antidepresivos IMAOs
- e) Anticonvulsivantes

71) Un paciente de 35 años presenta aumento de peso y debilidad, de 4 meses de evolución. Al examen físico se aprecia obesidad abdominal y facial, con atrofia muscular. Se solicita cortisol libre urinario de 24 horas, que resulta muy elevado y ACTH que resulta elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Enfermedad de Cushing
- b) Síndrome de Cushing por aporte exógeno de corticoides
- c) Síndrome de Cushing por hiperplasia suprarrenal
- ☒ d) Síndrome de Cushing por adenoma adrenal productor de cortisol
- e) Síndrome de secreción ectópica de ACTH

72) Un paciente de 67 años presenta problemas de memoria, de un año de evolución, asociado a conductas desadaptativas y agresividad ocasional, por lo que se indica quetiapina en bajas dosis, para controlar los síntomas. Sin embargo, luego de administrar el fármaco, los síntomas empeoran y se agrega temblor de la extremidad superior derecha y alucinaciones. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- a) Enfermedad de Alzheimer
- ☒ b) Demencia por cuerpos de Lewy
- c) Demencia frontotemporal
- d) Hidrocefalia normotensiva
- e) Delirium

73) Una paciente de 30 años consulta por dolor torácico intenso, que aumenta con la inspiración y que disminuye al adoptar una posición genupectoral. Se solicita un electrocardiograma que muestra elevación del segmento ST en V1 a V6. La creatininfosfoquinasa Mb es normal. La conducta más adecuada es:

- a) Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar trombólisis con estreptoquinasa
 - b) Anticoagular con heparina y realizar coronariografía de urgencia
 - c) Hospitalizar y solicitar angioTAC de tórax
 - ☒ d) Iniciar ibuprofeno oral
 - e) Solicitar dímero D
- ? Pericarditis?

74) Una paciente de 33 años consulta por cefalea de un mes de evolución, que ha ido en aumento y se ha asociado a vómitos en algunas oportunidades. Refiere que el dolor es de carácter opresivo y suele ser más intenso al despertar, llegando a despertarla en la noche, por dolor. Además, en una oportunidad presentó una convulsión tónico clónica, luego de la cual estuvo algo desorientada y con dificultades para caminar, las que se recuperaron. El diagnóstico más probable es:

- a) Hemorragia subaracnoidea X
 - b) Epilepsia primaria, con parálisis de Todd
 - c) Tumor cerebral
 - ☒ d) Trombosis de seno venoso cerebral
 - e) Accidente cerebrovascular lacunar
- ? trombo

75) Una mujer de 25 años inicia oligomenorrea, con ciclos menstruales cada 2 a 3 meses, a lo que se le agregan acné. Se solicitan exámenes, que muestran elevación de la LH y del estradiol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☒ a) Síndrome de ovario poliquístico
- b) Falla hipotalámica
- c) Hiperprolactinemia
- d) Falla ovárica X
- e) Insuficiencia hipofisiaria

76) Un paciente de 18 años, diabético tipo 1, en tratamiento, presenta compromiso de conciencia, de 20 minutos de evolución. Previo a esto presentó un cuadro de malestar general de 2 días de evolución, en contexto de una infección respiratoria. Al examen físico está en sopor profundo, con FR: 25x', saturación: 99%, FC: 120x' y PA: 100/60 mmHg. Su hemoglucotest resulta 450 mg/dl y se solicitan exámenes de laboratorio, que están pendientes. La primera medida es:

- ☒ a) Administrar suero fisiológico endovenoso
- b) Administrar bicarbonato endovenoso
- c) Administrar insulina endovenosa
- d) Administrar oxígeno por mascarilla
- e) Administrar suero glucosado endovenoso

77) Un paciente de 65 años presenta un síndrome nefrítico, asociado a insuficiencia renal grave, con creatinina de 5 mg/dl. La biopsia renal muestra formación de medialunas, con patrón paucimune a la inmunofluorescencia. El diagnóstico más probable es:

- ☒ a) Enfermedad de Good Pasture
- b) Enfermedad de Berger X
- c) Panarteritis nodosa
- d) Glomerulonefritis postinfecciosa X
- e) Poliangeítis microscópica

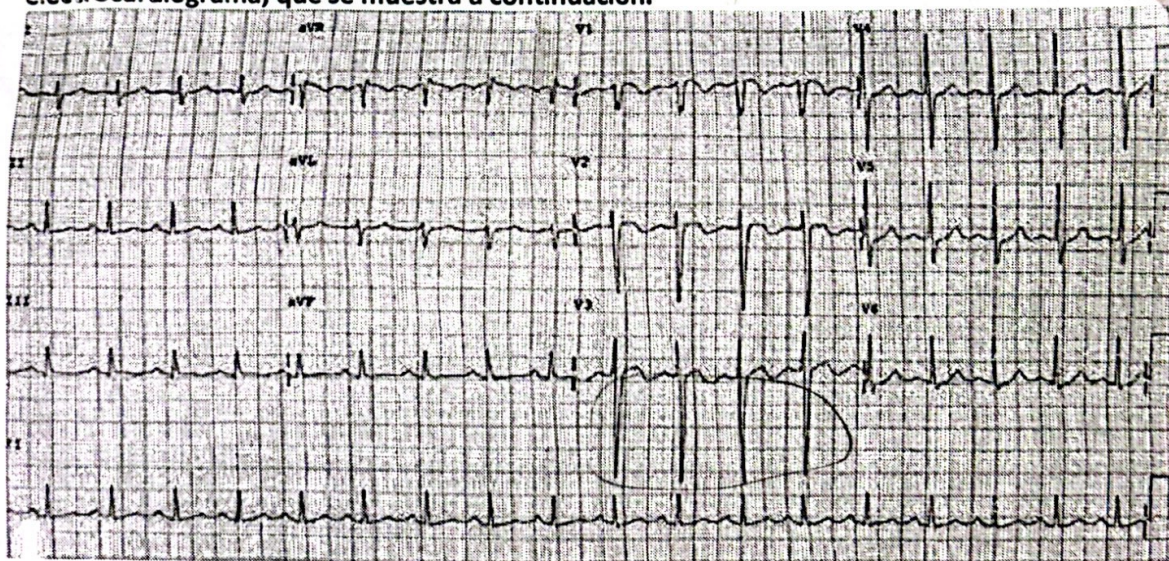
78) Un paciente se realiza serología para virus hepatotropos, con el siguiente resultado: Antígeno de superficie VHB (-), IgG VHBs (+), IgG VHBc (+), IgM VHBc (-), IgG VHC (-), IgM VHC (-). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Hepatitis B aguda
- b) Paciente sano, que tuvo hepatitis B y se recuperó
- c) Hepatitis B y C crónicas
- d) Hepatitis C
- e) Hepatitis B crónica

79) Un paciente presenta un síndrome polidipsico poliúrico de 3 semanas de evolución. Su glicemia de ayuno es normal y su examen físico no aporta mayor información. La conducta inicial más adecuada es:

- a) Solicitar cortisol basal e iniciar corticoides endovenoso
- b) Iniciar enalapril oral
- c) Iniciar furosemida oral
- d) Solicitar niveles plasmáticos de ADH
- e) Solicitar natremia, sodio urinario y osmolaridades plasmática y urinaria

80) Un paciente de 72 años presentó un accidente vascular isquémico hace un año, por lo que quedó semipostrado, con imposibilidad de caminar y dificultades para hablar. Se encuentra internado en un hogar de ancianos, en donde recibe cuidados multidisciplinarios. Presenta un cuadro de mayor desorientación y agitación desde hace 2 horas, razón por la cual se solicita evaluación médica. Al examen físico, presenta FC: 110x, PA: 96/60 mmHg, FR: 25x, T°: 36,0°C, saturación O2: 85% a FIO2 ambiental. Examen cardiopulmonar con ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos y murmulo pulmonar presente, sin ruidos agregados. Se solicita electrocardiograma, que se muestra a continuación.



Fuente imagen: www.litfl.com

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Infarto agudo al miocardio
- b) Accidente vascular embólico
- c) Hiperkalemia aguda X
- d) Neumonía aspirativa X
- e) Tromboembolismo pulmonar

FC = 110

81) Una paciente de 67 años acude a control ginecológico, en el cual se le palpa un tumor anexial derecho. Se solicita ecografía transvaginal que muestra un tumor multiloculado, de 6 cm de diámetro. El Ca-125 resulta 50 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Iniciar anticonceptivos orales y solicitar nueva ecografía en 3 meses
- b) Realizar punción-aspiración de la lesión y enviar a biopsia citológica
- c) Realizar seguimiento con Ca-125
- d) Tranquilizar a la paciente e indicar control ecográfico en 6 a 12 meses
- e) Realizar anexectomía con biopsia quirúrgica

82) Un lactante de 12 meses de edad presenta un cuadro de fiebre hasta 39,8 grados Celsius, sin otros síntomas, por lo que se solicita un sedimento de orina, por sonda, que muestra 10 leucocitos por campo y urocultivo, que está pendiente. Se inicia paracetamol y cefuroxime oral, presentando un exantema eritematoso, papular, en el tronco y la cara, al día siguiente. Su temperatura actual es 37°C. El diagnóstico más probable es:

- a) Alergia a las cefalosporinas
- b) Mononucleosis infecciosa
- c) Pielonefritis aguda
- d) Meningococcemia
- e) Exantema viral

fielore,

83) Un recién nacido presenta ictericia al segundo día de vida, que compromete todo el cuerpo, incluyendo las manos. Se realizan exámenes, entre los que se confirma bilirrubina de 30 mg/dl, con 25 mg/dl de bilirrubina indirecta. Además, se solicita hemograma que muestra hematocrito de 40%. Su grupo es A Rh negativo y el de su madre es O Rh positivo. Tiene un hermano de 2 años, que nació por parto vaginal y que no presentó complicaciones luego del parto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- a) Ictericia fisiológica
- b) Ictericia por hemólisis por incompatibilidad de grupo clásico
- c) Ictericia por hemólisis por incompatibilidad Rh
- d) Atresia biliar primaria
- e) Síndrome de Crigler Najjar

Diagnóstico

84) Una paciente de 50 años se realiza un PAP, que muestra displasias glandulares de alto grado. Se realiza colposcopia, con curetaje endocervical y biopsia, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

- a) Realizar biopsia endometrial
- b) Realizar cono frío
- c) Realizar cono con asa LEEP
- d) Realizar histerectomía
- e) Observar evolución

85) Una paciente presenta un embarazo de 40 semanas, que está en trabajo de parto. Al momento de la rotura de membrana, se produce salida de líquido amniótico claro, pero evoluciona rápidamente con deterioro del registro fetal, el que muestra una bradicardia fetal mantenida. El diagnóstico de sospecha es:

- a) Rotura uterina
- b) Rotura de vasa previa
- c) Abruption placentae
- d) Placenta previa
- e) Procidencia de cordón umbilical

86) Un recién nacido de 4 días de vida presenta disminución de su actividad y rechazo alimentario. Al examen físico, presenta t° : $35,0^{\circ}\text{C}$, tono muscular disminuido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- a) Observar evolución
- ☒ b) Solicitar hemograma
- c) Iniciar antibióticos orales
- d) Solicitar punción lumbar, hemograma y hemocultivos y decidir según resultados
- e) Solicitar punción lumbar, hemograma, hemocultivos, radiografía de tórax, sedimento de orina y urocultivo e iniciar antibióticos endovenosos de inmediato

87) Una paciente de 20 años, cursando un embarazo de 32 semanas, es diagnosticada de un síndrome hipertensivo del embarazo, mediante una semihospitalización, que presenta varias presiones arteriales cercanas a 150/100 mmHg. Se solicita una proteinuria cuantitativa, que resulta 500 mg/día. La conducta más adecuada es:

- ☒ a) Hospitalizar, solicitar exámenes de severidad de preclamsia y administrar corticoides endovenosos a la madre
- b) Iniciar alfametildopa y controlar ambulatoriamente
- c) Administrar labetalol endovenoso de inmediato
- d) Administrar sulfato de magnesio intravenoso de inmediato
- e) Realizar interrupción del embarazo

88) Un recién nacido de término presenta dificultad respiratoria al nacer. Además, llama la atención que babea continuamente. El diagnóstico más probable es:

- a) Hernia diafragmática congénita
- b) Atresia duodenal
- ☒ c) Botulismo neonatal
- d) Atresia esofágica
- e) Síndrome de aspiración de meconio

89) Una niña de 5 años presenta metrorragia de mal olor. Al examen físico se aprecia secreción hemopurulenta que proviene de la vagina. El diagnóstico más probable es:

- a) Himen imperforado complicado
- b) Abuso sexual
- c) Vulvovaginitis inespecífica
- ☒ d) Cuerpo extraño vaginal
- e) Cáncer de vagina

90) La profilaxis de sepsis neonatal por estreptococo grupo B, con ampicilina intravenosa durante el trabajo de parto, está indicada en una de las siguientes situaciones. ¿Cuál es?

- a) Más de 42 semanas de edad gestacional
- b) Diabetes mellitus gestacional
- ☒ c) Fiebre materna
- d) Preclamsia
- e) Restricción del crecimiento intrauterino